

جوستاف روسي انترناسيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إِسْمُ الْمَرِيضِ رِبَاعِيًّا : اَمَلُ فَايِزِ فَتُوْحِ رِضْوَانِ

المحافظة : الجيزة

الحى / المدينة : يولاق الذكرور

العنوان : بولاق الذكور الجيزة

رقم البطاقة : 27401081702205 رقم التليفون : 01110710319

تاريخ تسجيل الإستمارة : 05-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 08-01-1974 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----) التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التوقيع: (_____)

المقرر بما فيه

التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157]

الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة:

الوظيفة:

الوظيفة:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

-----/3 -----/3 -----/3.1 -----/3.1

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج :-

ملاحظات : ---

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

مدير عام

مديرية الشئون الصحية

ختم

شعار الجمهورية

--

Name: امل فايز فتوح رضوان National ID: 27401081702205	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

٢٠٢٤/١٠ ٢٧٤٠١٠٨١٧٠٢٢٠٥
 ربة منزل
 أنثى مسلمة متروجة
 عبدالناصر عبدالعظيم حافظ فخير
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢١/١٠/٠٤ ١





١٠٥٨٠

جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحقيق الشخصية
 ام
 هانيز فتوح رضوان
 ٣٢ سن محمد مصطفى الكائن
 بولاي الكروير - الجيزة
 ١٩٧٤/١٠ ٢٧٤٠١٠٨١٧٠٢٢٠٥
 KU0774680






Patient Name : الأستاذة / أمل فايز لثوح رضوان	Request No. : 13009616
Patient No. : 27401081702205	Request Date : 11/09/2024
Path No. : 3422/24	Verification Date : 30/09/2024
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 50 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 10/09/2024, 2:40 pm.

Gross Examination:

- Multiple grayish white tissue cores up to 1.5 cm, totally submitted.
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, Her2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
- * Ductal carcinoma in situ: Focal.
- * Perineural invasion: No.
- * Angiolymphatic invasion: No.
- * Microcalcification: Focal.
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
 - ER: Moderate nuclear reaction in 30% of tumor cells (score 5/8).
 - PR: Strong nuclear reaction in 80% tumor cells (score 8/8).
 - Her2: No membrane reaction in tumor cells (score 0).
 - Ki67: 25% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:

Invasive duct carcinoma, Grade II with focal DCIS and focal calcification.

IPT:

- ER: Positive (score 5/8).
- PR: Positive (score 8/8).

Verified by :

Dr. Sagda El-Kady

Printing Date : 06/02/2025 10:41:57

Page 1 of 2

Printing By : hermal



Name: <u>أمل فايز فتوح رضوان</u>		
MR. : <u>5929</u>		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشر بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient presented today with a performance status of 0 for arimidex therapy and supportive treatment. Physical examination revealed skin edema over the right breast, prompting a surgical consultation for BSM in December 2025. A free chest X-ray was ordered and no findings were reported.		
The patient is a peri-menopausal woman with right breast carcinoma, invasive ductal carcinoma, hormone receptor positive, HER2 negative. She underwent upfront wide local excision with axillary lymph node dissection, staged pT2N2M0. Adjuvant chemotherapy consisted of 4 cycles of doxorubicin/cyclophosphamide (AC) followed by 4 cycles of docetaxel (TXT). Post-operative radiation therapy was administered. Since July 2025 the patient has been receiving arimidex and zoladex; the last zoladex injection was given on 22 February 2026. She is currently on arimidex, zoladex, calcium, vitamin D, and has begun a second cycle of zoledronic acid (C2).		
The patient was again seen for arimidex and supportive therapy. A new assessment was pending as of 16 June 2026.		
On 7 September 2026 the patient was reviewed for zoladex and arimidex with supportive therapy for three months. She reported a partial pause in treatment (P PAUS) on 16 June 2026. Imaging revealed fatty liver and gallbladder calculi on abdominal ultrasound. Echocardiography on 20 June 2026 showed an ejection fraction of 67 %. No further interventions were documented.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 20-09-2026
Reham Ahmed Fathy Ibrahim		الطبيب المعالج :
يعتمد ,		



Patient Name : الأستاذة / امل فايز فتوح رضوان

Patient No. : 27401081702205

Path No. : 5129/24

Sex : Female

Age : 50 Y

Referring Doc :

Request No. : 13007563

Request Date : 22/12/2024

Verification Date : 30/12/2024

Financial Category : نفقة الدولة - ارقام دار السلام

Department : Out Patient

Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

• Additional pathologic findings: Positive calcification

Diagnosis:

Right WLE & Right ALN biopsy:

Invasive duct carcinoma Grade II with DCIS(25 %)

• Positive LNs (4/20)

• Free margins

• Stage : pT2 , pN2

• Dr. Rana Fathy

Dr.Heba Hassan

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 06/02/2025 10:42:29

Page 2 of 2

Printing By : hermal



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt



Patient Name : الأستاذة / أمل فايز فتوح رضوان

Patient No. : 27401081702205

Path No. : 5129/24

Sex : Female

Age : 50 Y

Referring Doc :

Request No. : 13007563

Request Date : 22/12/2024

Verification Date : 30/12/2024

Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام

Department : Out Patient

Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data : Right breast cancer

Nature of the specimen : Right WLE & Right ALN biopsy

Gross Examination:

• Procedure: Right WLE specimen measured 6x5x2.5 cm , covering skin ellipse measured 5 x 1.5 cm .

• Tumor extent : A well defined greyish white firm mass measured 4x2.5x1.7 cm .

• Distance from margins: (0.3, 0.2 ,1.7 ,0.1 ,1.5,&2.5_ cm away from (lateral , medial,superior,inferior, deep &skin) margin ,

• Lymph nodes number and size: A fibrofatty tissue piece measured 6x5 cm enclosing 20 ALNs up to 1.5x1 cm .

• Frozen section: Free margins

Blocks:

1.lateral

2. medial

3.superior

4.inferior

5.deep

6,7,8,9,10,11. .mass

12,13,14 .lymph nodes

Grossing by :Dr.Yasmine Essam

Microscopic examination:

• Histological type: Invasive duct carcinoma

• Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)

• Angiolinvasion:Positive

• Ductal carcinoma in situ: present (25 %), mainly solid and comedo

• Lymph node involvement: Positive SLNs (4/20)

• Resection Margins: Free margins

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 06/02/2025 10:42:29

Page 1 of 2

Printing By : hermal



Name: Amal Faeyz Fatouh

Date: -19/10/2024

R: 27373

Prof DR.

I-POST CONTRAST C.T. SCAN OF THE CHEST REVEALED :-

- Non uniform (mosaic) aeration of both lungs.
- Otherwise, Clear both lungs showing no definite nodules, masses or cavitary lesions.
- Clear both costophrenic recesses .
- Mild cardiomegally with no pericardial effusion
- No evidence of hilar/mediastinal lymphadenopathy .

II-POST CONTRAST C.T. ABDOMEN AND PELVIS REVEALED :-

- Tiny gall bladder stone is noted.
- Average sized liver showing homogenous texture and regular smooth outlines. No definite focal lesions or dilated IHBRs.
- Patent main portal vein and its central branches.
- Average sized spleen showing no definite focal lesions.
- Normal CT appearance of the pancreas, adrenal glands, kidneys, aorta and IVC.
- Intact pelvic organs.
- No retro-crural or retro-peritoneal lymph nodes are noted.
- No ascites.
- Clear scanned lung bases.


Dr. Ahmed Badr
S.A

Prof. Dr. Magdy Bassiouni



Patient Name: Amal Fayez Fattouh Radwan	Date : 13/11/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 51 Year(s)
Medical ID: 3502/2024	Pat. ID: 94205

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indication:

right breast pathologically proved carcinoma.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Right breast shows UOQ architectural distortion lesion, of high density.
- Complementary ultrasound revealed right breast parenchymal distortion with increased vascularity detected within on color Doppler, seen at 10 o'clock position 20mm from the nipple, 3.7mm from the overlying skin, measuring 40x21mm, with Q anterior ductal extension about 32mm.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex of the left breast.
- no Left solid mass or cystic lesion.
- Pathological right axillary lymph nodes (more than 3nodes) are seen with muffled hila, measuring 16x11mm,
- Nonspecific left axillary LN.

Opinion:

- Right breast UOQ pathologically proved carcinoma with Q anterior ductal extension (BIRADS 6)
- Pathological right axillary LNs seen at level I (more than 3nodes).
- Benign findings left breast (BIRADS 2)

Signature Dr. Nehal Hamdy

13/11/2024 3:53 PM



A- Patient ID:

1- Name: **مريم فلاح رضوان**

Sex:

MDT form

3- Medical number:

Female

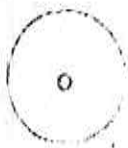
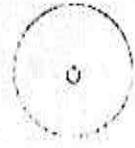
83235702

Old Med:

3502-2024

Patient Age: 51 Y

2- ID number:



Family history

Family history

Phone

01122750782

BMI

Marital status

Marital status

NRS Score

NRS Score

GROUP

Co morbidity

Co morbidity

Menopausal status

Menopausal status

Initial STAGE

REASON OF MDT

REASON OF MDT

Date of MDT

2025-01-20

Breast Imaging:

rt breast solitary mass at 10 o'clock measuring 2.6x1.8 cm+IPALN

Clinical data

Mets Workup:
ct cap:free

BX IDC focal DCIS	ER 5/8	PR 8/8	Her 2 Neu 0	SISH	Ki67 25
-------------------------	-----------	-----------	----------------	------	------------

T P2	N 2	M 0
---------	--------	--------

Sonomammography

PATIENT HISTORY

RT WLE+ALND: free surgical margin
In +ve 4/20

MDT OUTCOME & PLAN

FOR ADJ 4 AC/ 4 TXT, PORT& AI +/- ZOLADEX AFTER E2 ASSESSMENT

MEDICAL ONCOLOGY		SIGNATURE	
SURGERY		RADIOLOGY	
Psychiatric		PATHOLOGY	
		Nutrition	

Name : Amal Faiz Fattouh Radwan

Date : 03-11-2025 10:17

Branch : Dokki

Medical No. : 240074

Ref.Physician Prof : Gostaf Roseh Hospital

Ins.Company : تعاقد مستشفيات

Tc^{99m} MDPSKELETAL SCINTIGRAPHY

History

- A 51-year-old patient, with history of breast cancer and referred for metastatic workup.

Technique

- Anterior and posterior whole-body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings

- No abnormal active or cold focal bony lesions that could account for metastatic bone disease.
- Degenerative changes are noted at the spine and big joints.

Impression:

- The skeleton is free from metastases.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine

